Early deceleration

1. 태아심박이 오목하게 쭉 내려가는걸 deceleration이라고 하는데, 없는게 정상이고, 있으면 유심히 봐야한다.
2. 단, 자궁수축 타이밍에 딱 맞게 decel된다면 이거는 정상이다. (자궁수축이 태아머리를 눌러서 그런 거임.)

양막파수(±) 진통(±)

1. 양막파수(+)이면 항생제(페니/암피) 준다.
2. 양막파수(+) 산모가 자궁압통(+) 발열(+)이면 융모양막염이라서 즉시 낳아야 한다.
3. 33주까지는 폐성숙 스테로이드를 줘야하며, 양막파수(+) and 진통(+)이어야만 분만실 가서 개대를 기다린다. (진통만 있으면 진통진통제 주고 시간 끈다.)
4. 34주부터는 스테로이드 필요없고, 양막파수(+) or 진통(+) 이어도 분만실 가서 개대를 기다린다.

조산예방

1. 경부≤2.5cm(+) or 조산력(+)이면 P주면 좋다.
2. 경부≤2.5cm(+) and 조산력(+) and <24주(+)이면 경부 결찰술까지 시행한다.

≥41주

1. 41주 부터는 전자간증/변이도감소/양수과소증 하나라도 있으면 옥시토신으로 유도분만 해보고, 다 멀쩡하면 42주까지 기다린다.
2. 42주 부터는 무조건 옥시토신으로 유도분만 해보지만, 유도분만 실패했으면 옥시토신을 더 주는게 아니라 3일 후 다시 시도해본다.

경부개대／하강도 지연

1. 규칙적수축있다는 전제하에 , 경부개대 <6cm를 잠복기, 6~10cm를 활성기라고 정의한다.
2. 미(다)분만부가 잠복기에 있으면 20(14)시간 동안 지켜보고, 20(14)시간 넘게 잠복기이면 잠복기 지연장애로 진단하고, 경과관찰~옥시토신~양막파열을 시도한다.
3. 활성기인데 1시간에 1cm보다 적게 열리면 활성기 지연장애로 진단하고, 경과관찰~옥시토신~양막파열을 시도한다.
4. 활성기인데 2시간 넘게 전혀 열리지 않으면 활성기 정지장애로 진단하고, 얼른 분만해야 하는데, 10분간 자궁수축 합계가 <200(+)이면 옥시토신을 주고, >200(+)이면 제왕절개 한다.
5. ≥10cm 부터는 분만2기라고 부르는데, 아두가 완전히 보이기 때문에, 처치가 좀 달라진다. 분만2기에서 미(다)분만부가 3(2)시간 동안 정지해있으면 겸자/흡입으로 애기머리 잡고 끄집어 빼면 된다. 다만, 경막외마취(+)이면 1시간 씩 더 지켜본다.

다태임신

1. 단일융모막.이중양막.쌍둥이에서 한쪽은 양수과소/한쪽은 양수과다 이면 쌍둥이간 수혈증후군으로, 레이저 혈관 절제술 해야한다.
2. 일측태아사망은 끄집어 내는게 아니라 경과관찰한다.

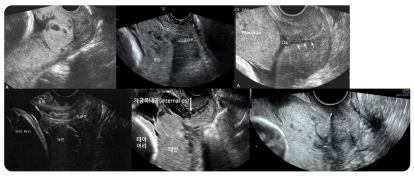
둔위

1. 둔위/횡위는 36주부터 교정술을 시도해보고, 진통시 제왕절개로 낳는다.
2. 나머지 태위는 진통시 질식분만으로 낳는다.

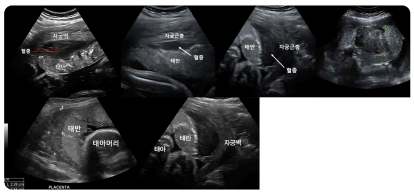
산전관리

1. 초음파 검사중 어지럽거나 혈압이 낮아지면, 자궁이 대동맥을 압박한거니까 옆으로 눕히면 된다.
2. 염색체이상/신경관결손의 선별검사는, 1분기에는 목덜미투명대를 보며, 2분기에는 Quad test를 한다. 요즘은 Cell-free DNA라고 분기와 상관없는 선별검사도 있다. 2분기 Quad test에서 AFP가 높게 나왔다고 해서, 바로 확진검사를 하는게 아니라, 초음파로 주수를 확인해야 한다.
3. 염색체이상/신경관결손의 확진검사는 1분기에는 융모막생검을 하며, 2분기에는 양수천자를 한다.
4. 산모가 Rh(-) 라면 항D면역글로불린(Rhogam) 줘야한다.
5. 산모가 근종/낭종 좀 있을 수도 있지만, 만약 혈역학적불안정/반동압통/난소꼬임 있다면, 임신을 유지하면서 절제술을 하고, 난소까지 절제했어도, 프로게스테론 보충하면 괜찮다.

전치태반

1. 태반에서 피가 나는거라서, 흠뻑 나와도 통증이 경할 수 있다.
2. 초음파로 아두-태반-경부 순서임을 확인하면 된다.
   - 
3. 산모가 위험(혈역학적 불안정)하거나 태아가 위험(Late decel)하면 제왕절개하고, 그렇지 않으면 지켜봐도 된다.

태반조기박리

1. 갑자기 또는 외상후 복통과 함께 피가 난다.
2. 초음파로 태반-혈종-자궁벽 순서임을 확인하면 된다.
   - 
3. 산모가 위험(혈역학적 불안정)하거나 태아가 위험(Late decel)하면 제왕절개하고, 그렇지 않으면 지켜봐도 된다.

산후질환

1. 분만직후 호흡곤란/혈역학적 불안정/DIC(+)인 양수색전증이 올 수 있다.
2. 산후 냄새나는 노란색 질/자궁목 분비물(+)은 오로(내막염)이고, 항생제 먹어야 한다.
3. 산후 유방통증은 발적 없으면 유방울혈이라 보존적치료하면되고, 발적 있으면 유방염이라 항생제 먹어야 한다. 저에코 덩이 까지 있으면 농양이라 배농해야한다.
4. 산후 우울증은 10일까지는 지켜본다.

산후출혈

1. 아무 특이소견도 없으면 질/경부 열상이다.
2. 자궁이 물렁하게/배꼽위에서 만져지면 자궁이 수축을 못해서 지혈이 안되는 자궁이완증(퇴축부전)이다. 옥시토신/카베토신/에르고노빈 으로 수축시키면 된다.
3. 고에코 덩이(+)이면 잔류태반이고, 남은걸 제거하면 된다.
4. 질밖에서 보이거나, 경부에서 만져지면 자궁내/외번증이고, 도수정복해야 한다.
5. 외음부혈종(+)인데 혈역학적 불안정(+)이면 혈관 결찰술/색전술 해야한다.

수두／풍진／B형간염

1. 산모의 수두발진시작일로부터 5일 내에 분만했다면, 면역글로불린을 줘야한다. 5일로는 산모항체가 전달될 시간이 불충분했다고 보기 때문이다.
2. 산모 풍진은 IgM(-) IgG(+) 이라면 면역력이 있는거지만, 그렇지 않다면 재검해야 한다. 재검했더니 급성감염소견(양전, 역가상승, 결합능감소)이 발견됐다면 중절상담 해야한다.
3. HBsAg(+) 산모가 분만했으면, 주사침사고와 똑같이 면역글로불린+B형간염 백신을 준다.

양수 과소증／과다증

1. 일단 숫자를 외워야한다. 양수지수는 정상이 5~24cm이고, 최대양수깊이는 정상이 2~8cm이다.
2. 양수과소증은 전자간증 등이 원인이며, 태아성장지연을 만든다.
3. 양수과다증은 샘창자폐색 등이 원인이며, 딱히 문제는 없어서 지켜보면 되지만, 산모가 압박증상을 느낀다면 감압술 한다.

유산

1. 경부도 열리고 양막도 터져서 불가피하게 낳아야 하는게 불가피유산
2. 심박동이 없어지거나 hCG가 갑자기 감소하는게 계류유산(자궁내태아사망)이며, 임신낭/태아가 안보이면 hCG 추적하며 희망가져보고, 그렇지 않다면 유도분만 해야한다. 악취까지 난다면 긁어냄술도 해야함.
3. 절박유산은 그냥 임신중 질출혈하는거로, 딱히 유산이 아니다. 지켜보면 된다.
4. 반복 유산의 원인 중 하나로, 항인지질항체 증후군이 있는데, 항체 이름이 항인지질항체는 아니고, 루푸스항응고/항카디오리핀/항베타당단백 항체여서 이 3개 이름을 외워야 한다. 이것들이 양성이 나오면, 12주뒤 재검해서 2회 연속 양성임을 확인한 후, 아스피린+헤파린으로 치료한다.

입덧

1. 입덧은 B6(피리독신)으로 치료한다.

전자간증

1. ≥20주에 발견된 고혈압이, 신장/간/혈소판이 안 좋은 상태를 전자간증이라고 부르며, 혈압이 160을 넘는 경우를 중증 전자간증이라고 부른다.
2. 중증전자간증에서는 라베탈롤/히드랄라진/니페디핀으로 혈압을 낮추며, 황산마그네슘으로 경련을 예방한다.
3. 유도분만하는 주수를 요약하자면, "덜 심각하면 36주까지 참고, 심각하면 33주까지만 참는다."
4. 그러나 중증 전자간증에서 폐부종/경련(+)일 경우 33주까지 못참는다, 바로 유도분만 해야한다.
5. 뭔가 급박해보이니까 낚시선지로 제왕절개가 자주나오는데, 혈압약 주면서 유도분만하면 된다.
6. 황상마그네슘 복용중 DTR이 떨어지면 글루콘산 칼슘을 먹으면 된다.

태아성장지연(예측몸무게≤9백분위수)

1. 예측몸무게≤9백분위수(+)를 태아성장지연이라고 부른다.
2. 태아성장지연에서 risk factor는 3개가 있다: 이완기역류, 이완기없음, 양수과소증
3. 38주 부터는 충분히 컸으니 risk factor 하나도 없어도 분만하면 된다.
4. 34주~37주는 이완기역류(+) or 이완기없음(+) or 양수과소증(+) 있으면 분만한다.
5. 33주 이하는 최대한 끌어보고 싶다. 이완기역류(+)아니면 참는다.